

Fecha Última Actualización: 23-05-2022 13:38:00

Página 1 de 3

Información Paciente

Nombre : Julio Alfonso Ramirez Jeldres
Edad : 63a 5m 21d
Dirección : Pje. Sn Luis 278 V. Sta. Elvira

Rut : 9.320.331-3
Fecha Nacto: 02/12/1958
Comuna : Puente Alto

N° Archivo : 1520451
Sexo : Masculino
Teléfono : 9 8788 8995

N° Epicrisis
308230

Información Hospitalización

Unidad de Ingreso : Upc - Uci Adulto

Fecha Ingreso : 09/05/2022 19:26

Días Estadía: 14

Unidad de Egreso : Upc - Uci Adulto

Fecha Egreso : 23/05/2022 13:05

Motivo o Diagnóstico de Ingreso

Compromiso de conciencia

Comorbilidades

Procedimientos

Intervenciones Quirúrgicas

Epidemiología

Resumen Clínico

Epicrisis

Nombre: Julio Alfonso Ramirez Jeldres
RUT: 9320331-3
Edad: 63 años
FI CASR: 09/05/22
Contacto: Bella (hermana) 956664633.

Anamnesis remota

- Mórbitos: HTA y DM2, ambos sin adherencia al tratamiento
- Quirúrgicos: amputación supracondílea extremidad inferior derecha enero 2020 en contexto diabetes mal controlada.
- Alergias: se desconoce.
- Inmunizaciones: se desconoce.
- Social: dependiente para las actividades básicas de la vida diaria.

Anamnesis próxima

Paciente con antecedentes descritos, familiar lo encuentra comprometido de conciencia en domicilio, llama a SAMU quien traslada hasta reanimador de UE CASR. Paciente ingresa en malas condiciones generales, hipotenso, desaturando, GCS 11 puntos y HGT 570. Al examen físico destaca extremidad inferior izquierda maloliente, necrótica, con pulso palpable sólo a nivel femoral. Se avisa caso a equipo de cirugía de turno quienes indican amputación de extremidad. Durante estadía en urgencia se realizan exámenes de laboratorio donde destaca parámetros inflamatorios elevados, acidosis metabólica con AG aumentado no compensada, osmolaridad calculada aumentada (323), INR prolongado de forma espontánea, falla renal aguda y alteración de pruebas hepáticas. Dado síndrome hiperosmolar hiperglicémico/trastorno mixto y shock séptico, se inicia reanimación con cristaloideos, DVA, BIC de insulina y plasma fresco congelado.

En pabellón se realiza amputación supracondílea de extremidad inferior izquierda, sin incidentes.

Se decide traslado a UPC para continuar manejo.

Diagnósticos de ingreso:

Shock séptico foco cutáneo-osteomuscular.

Amputación supracondílea extremidad inferior izquierda.

Fecha Epicrisis : 23/05/2022 13:38

Página 1 de 3

Fecha Última Actualización: 23-05-2022 13:38:00

Página 2 de 3

Síndrome hiperosmolar hiperglicémico.
Falla renal aguda
Acidosis metabólica con anión GAP aumentado, no compensada.

Evolución por sistema en UCI

Hemodinamia: ingresa en shock séptico y falla multiorgánica, con aumento progresivo de noradrenalina, criterios de hipoperfusión y corazón hipocontractil a la ecoscopia, por lo que requiere soporte con dobutamina.
Evoluciona desfavorablemente, con segundo episodio de shock séptico asociado a falla multiorgánica, noradrenalina en altas dosis y mala perfusión clínica.
Se decide proporcionalidad dado contexto y basal del paciente.

Ventilatorio: VMI secundario a compromiso de conciencia, shock séptico y cirugía. Sin mayor compromiso ventilatorio durante estadía en UCI.

Metabólico: ingresa con DM2 descompensada, patrón mixto de CAD/SHH. Manejo con cristaloides y BIC de insulina. Se logró resolver.

Infectología: ingresa en shock séptico de foco cutáneo, secundario a pie diabético y enfermedad arterial oclusiva severa de extremidad inferior izquierda, asociado a falla multiorgánica. Se realiza amputación supracondílea de pierna izquierda. Sin microbiología aislada.
Evolución desfavorable, sin respuesta a terapia antibiótica.

Gastro: Sin antecedente de DHC, ingresa con alteración de pruebas hepáticas de predominio hepatocelular asociado a hiperbilirrubinemia en contexto de shock séptico. Evolución inicial favorable, con mejoría de pruebas hepáticas pero deteriorándose nuevamente en contexto de nuevo shock séptico.

Nefrología: AKI KDIGO desconocido, ingresa con crea 2.1, con buena respuesta a reanimación. Evoluciona con AKI post renal por obstrucción de CUP, resuelta. Evoluciona nuevamente con falla renal en contexto de nuevo shock séptico.

En síntesis, paciente con mala evolución clínica, sin respuesta a manejo de shock séptico, fuera de alcance terapéutico.
FALLECE A LAS 13: 20 HORAS DEL 23/05/2022.
EMITIDO CERTIFICADO DE DEFUNCIÓN A LA FAMILIA.

Diagnóstico de Egreso

OTRAS SEPSIS ESTREPTOCÓCICAS -
INSUFICIENCIA RENAL AGUDA -
INSUFICIENCIA RESPIRATORIA AGUDA -
INSUFICIENCIA HEPATICA, NO ESPECIFICADA -

Condición de Egreso Fallecido

Egreso con Catéter Doble J:NO

FALLECIDO

Plan Post Alta

FALLECIDO

Indicaciones

Tipo de Reposo :

Régimen Alimentario :

Medicamentos :

Controles

Fecha Epicrisis : 23/05/2022 13:38

Página 2 de 3



Epicrisis Hospitalaria

ESTADO: DEFINITIVA



COMPLEJO ASISTENCIAL

DR. SÓTERO DEL RÍO

JUNTOS PARA UNA MEJOR SALUD

Fecha Última Actualización: 23-05-2022 13:38:00

Página 3 de 3

INTERNO

Becado/Residente

Carlos Alarcon Silva

Médico Tratante (Staff)